

Indicación quirúrgica y pronóstico visual

1. Introducción y relevancia clínica

La **catarata** es la **principal causa de ceguera reversible** a nivel mundial y nacional. En Chile, constituye una de las patologías oftalmológicas con cobertura **GES (Garantías Explícitas en Salud)**, garantizando evaluación y tratamiento quirúrgico a los pacientes con **discapacidad visual bilateral** causada por esta enfermedad.

La **cirugía de catarata con implante de lente intraocular (LIO)** es el **tratamiento estándar y curativo**, y ha evolucionado hasta ser uno de los **procedimientos quirúrgicos más seguros y exitosos** de la medicina moderna.

La indicación quirúrgica depende no solo del grado de opacidad del cristalino, sino del **impacto funcional sobre la calidad de vida del paciente**, y de su **situación visual global** (monocularidad, comorbilidades oculares, necesidades laborales, etc.).

El médico general debe conocer los **criterios clínicos de derivación**, las **indicaciones quirúrgicas absolutas y relativas**, y el **pronóstico visual postoperatorio**, ya que estas situaciones son frecuentes tanto en la práctica asistencial como en el **EUNACOM**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El cristalino actúa como una **lente transparente biconvexa** encargada de enfocar los rayos luminosos en la retina.

La opacificación —catarata— produce **dispersión y absorción de la luz**, disminuyendo la visión central y periférica, el contraste y la percepción de colores.

El tratamiento quirúrgico consiste en **extraer el cristalino opacificado** y reemplazarlo por un **lente intraocular (LIO)** que restaura la refracción del ojo.

Existen diferentes técnicas quirúrgicas:

- **Facoemulsificación con LIO (técnica estándar actual).**
- **Extracción extracapsular manual (EECC).**
- **Extracción intracapsular (EICC)** – en desuso salvo luxaciones totales.

El éxito visual depende de:

- La técnica utilizada.
 - La ausencia de patologías oculares asociadas (glaucoma, DMAE, retinopatía diabética).
 - El control de complicaciones intra y postoperatorias.
-

3. Criterios de indicación quirúrgica

3.1 Indicaciones funcionales (más comunes)

La cirugía se indica cuando la **disminución visual afecta la calidad de vida o el desempeño funcional del paciente**, independientemente del grado anatómico de opacidad.

Criterios clínicos:

- Agudeza visual corregida $\leq 20/60$ (0,3) o peor.
 - Dificultad para realizar actividades cotidianas (lectura, conducción, trabajo).
 - Deslumbramiento incapacitante (p. ej., conducción nocturna).
 - Miopización progresiva por catarata nuclear (“cambio de anteojos frecuente”).
 - Deseo del paciente de mejorar su visión funcional tras evaluación oftalmológica.
-

3.2 Indicaciones médicas o terapéuticas

La cirugía es necesaria **independientemente de la agudeza visual**, en casos donde la catarata compromete la estructura o función ocular:

Indicaciones médicas	Descripción
Glaucoma facomórfico o facolítico	Opacidad madura que eleva la PIO por bloqueo pupilar o fuga proteica.

Catarata hipermadura o intumesciente	Riesgo de rotura capsular y complicaciones inflamatorias.
Visualización de fondo necesaria	Ej. evaluación o tratamiento de retinopatía diabética, DMAE o desprendimiento de retina.
Trauma ocular con catarata y luxación	Riesgo de inflamación o pérdida visual.
Catarata congénita bilateral	Riesgo de ambliopía irreversible.
Catarata unilocular severa en niño	Debe operarse antes de los 3 meses para evitar ambliopía.

3.3 Indicaciones refractivas o relativas

- **Deseo de independencia óptica** (miopía alta, anisometropía, pacientes pseudofáquicos contralaterales).
- **Reemplazo de lente intraocular previo defectuoso.**
- **Catarata incipiente asociada a cirugía combinada** (p. ej., cirugía de glaucoma).

4. Contraindicaciones quirúrgicas

Aunque la cirugía es segura, existen situaciones en que debe **posponerse o evitarse** temporalmente:

Tipo	Ejemplos	Conducta
Absolutas (raras)	Endoftalmitis activa, úlcera corneal, trauma ocular no estabilizado.	Tratar proceso activo antes de cirugía.

Relativas	Retinopatía diabética proliferativa, DMAE avanzada, neuropatía óptica, uveítis no controlada.	Evaluar riesgo/beneficio; posible cirugía combinada o diferida.
Sistémicas	Infección sistémica grave, descompensación metabólica, HTA o DM no controladas.	Control previo con médico tratante.

5. Evaluación preoperatoria

Todo paciente candidato a cirugía debe someterse a una **evaluación oftalmológica completa**, que incluye:

Examen	Objetivo
Agudeza visual	Cuantificar grado de discapacidad.
Biomicroscopía	Confirmar tipo y densidad de catarata.
Tonometría	Evaluar PIO y descartar glaucoma.
Fondo de ojo (si es posible)	Evaluar retina y nervio óptico.
Ecografía ocular (modo B)	Obligatoria si catarata densa impide visualizar retina.
Biometría y queratometría	Calcular poder dióptrico del LIO.
Topografía corneal / Paquimetría	Complementarios en casos especiales.

6. Procedimiento quirúrgico

6.1 Técnica estándar: Facoemulsificación con implante de LIO

- Microincisión corneal (2–3 mm).
- Fragmentación ultrasónica del núcleo del cristalino.
- Aspiración de restos corticales.
- Inserción de **lente intraocular plegable** en saco capsular posterior.

Ventajas:

- Recuperación rápida (24–48 h).
- Menor astigmatismo inducido.
- Anestesia tópica (no requiere hospitalización).

Técnicas alternativas:

- **EECC (extracción extracapsular)**: útil en cataratas muy densas o cuando no se dispone de faco.
 - **EICC (intracapsular)**: actualmente en desuso salvo luxación total del cristalino.
-

7. Criterios GES (MINSAL – Chile)

Población beneficiaria:

- Personas con **discapacidad visual bilateral** por catarata.

Garantías GES:

Etapa	Descripción	Plazo
Confirmación diagnóstica	Evaluación oftalmológica y confirmación de catarata bilateral.	≤ 180 días desde sospecha.
Tratamiento quirúrgico	Cirugía con implante de LIO en al menos un ojo.	≤ 180 días desde confirmación.
Rehabilitación visual	Control postoperatorio y entrega de lentes correctores.	≤ 30 días desde cirugía.

8. Complicaciones quirúrgicas

8.1 Intraoperatorias

- **Rotura capsular posterior** (más frecuente, 1–2%).
- **Pérdida vítrea.**
- **Luxación del núcleo al vítreo.**
- **Hemorragia expulsiva (rara, grave).**

8.2 Postoperatorias tempranas

- **Edema corneal o macular.**
- **Inflamación severa / uveítis.**
- **Aumento de la PIO.**
- **Descentración del LIO.**

8.3 Postoperatorias tardías

- **Opacificación capsular posterior (OCP):** la más frecuente, tratable con **láser YAG** capsulotomía.

- Desprendimiento de retina.
 - Endoftalmitis (grave, <0.1%).
-

9. Pronóstico visual

9.1 Resultados generales

- >95% de los pacientes alcanza visión funcional (>20/40).
- 85–90% logra visión igual o mejor que antes de la opacificación.
- Pronóstico excelente en catarata senil sin comorbilidades.

9.2 Factores que empeoran el pronóstico

Factor	Impacto
Patología retiniana (DMAE, retinopatía diabética)	Limitan la recuperación visual.
Glaucoma avanzado	Pérdida irreversible de fibras nerviosas.
Cirugía complicada (rotura capsular, endoftalmitis)	Retrasa o impide recuperación total.
Ametropías no corregidas	Requieren lentes postoperatorios o cirugía refractiva adicional.

9.3 Pronóstico en situaciones especiales

- **Catarata congénita:** excelente si cirugía antes de los 3 meses + rehabilitación visual.
- **Catarata traumática:** variable según daño ocular asociado.

- **Catarata diabética:** buena si control metabólico adecuado y retina estable.
-

10. Rehabilitación visual postoperatoria

- **Controles oftalmológicos:** a 1 día, 1 semana, 1 mes y 3 meses.
 - **Uso de colirios postoperatorios:** AINEs + antibióticos + corticoides.
 - **Corrección óptica final:** entre 4–6 semanas post cirugía.
 - **Educación del paciente:** signos de alarma (dolor intenso, pérdida súbita de visión, secreción purulenta).
-

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. La **cirugía de catarata con LIO** es el **único tratamiento efectivo**.
 2. La **indicación es funcional**, no solo anatómica: se opera cuando afecta la calidad de vida.
 3. En **glaucoma facomórfico**, la cirugía es **urgente**.
 4. La **opacificación capsular posterior** es la complicación tardía más frecuente y se trata con **láser YAG**.
 5. La cirugía **no mejora la visión** si existe daño retiniano severo previo.
 6. La **evaluación preoperatoria completa (biometría, fondo de ojo, ecografía)** predice el resultado.
 7. En **niños**, la cirugía precoz previene **ambliopía irreversible**.
-

Errores comunes

- Operar basándose solo en hallazgo anatómico, sin valorar funcionalidad.

- No realizar tonometría previa (glaucoma oculto).
 - Omitir evaluación de fondo de ojo o ecografía antes de cirugía.
 - No informar al paciente sobre limitaciones visuales por patologías retinianas.
 - Ignorar control postoperatorio o no instruir sobre signos de alarma.
-

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **cirugía con implante de LIO** es el **tratamiento curativo y estándar** de la catarata.
2. La **indicación quirúrgica es funcional**, basada en el impacto visual y calidad de vida.
3. La cirugía también es **terapéutica** ante glaucoma facomórfico, hipermadurez o necesidad diagnóstica del fondo de ojo.
4. El **procedimiento de elección** es la **facoemulsificación con LIO**, de bajo riesgo y rápida recuperación.
5. El **pronóstico visual es excelente (>90%)** si no existen enfermedades oculares asociadas.
6. La complicación tardía más frecuente es la **opacificación capsular posterior**, tratable con láser YAG.
7. La **evaluación preoperatoria completa y el control postoperatorio** son claves para el éxito quirúrgico.